

TEMA 4.5 • GASTROENTEROLOGÍA

Hemorragias Digestivas

PERFIL EUNACOM 1.07.2.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción y Definiciones

La hemorragia digestiva es una de las urgencias más frecuentes en gastroenterología y cirugía. Su clasificación principal se basa en la relación anatómica con el **Ángulo de Treitz** (músculo suspensorio del duodeno):

Hemorragia Digestiva Alta (HDA): Sangrado que se origina por encima del ángulo de Treitz (esófago, estómago o duodeno). **Hemorragia Digestiva Baja (HDB):** Sangrado que se origina por debajo del ángulo de Treitz (intestino delgado distal, colon, recto o ano).

Manifestaciones Clínicas

Aunque la clínica puede superponerse, existen signos clásicos que orientan hacia el origen del sangrado:

TABLA 4.5.1: TÉRMINO VS DEFINICIÓN

TÉRMINO	DEFINICIÓN	ORIENTACIÓN
Hematemesis	Vómito de sangre fresca o "en borra de café".	Sugiere fuertemente HDA.
Melena	Deposiciones negras, alquitranadas, pegajosas y de muy mal olor (sangre digerida).	Típica de HDA (requiere al menos 8 horas de permanencia de la sangre en el tubo digestivo).
Hematoquecia	Eliminación de deposiciones mezcladas con sangre fresca o coágulos.	Generalmente sugiere HDB, pero puede verse en HDA masiva.
Rectorragia	Eliminación de sangre fresca, pura, sin mezcla con deposiciones, a través del ano.	Sugiere origen en el colon distal o recto (HDB).

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del Hematocrito: En un sangrado agudo, el hematocrito inicial suele ser **normal**. Esto ocurre porque se pierde sangre completa (plasma y elementos figurados) proporcionalmente. La anemia se hace evidente horas después, cuando el cuerpo compensa el volumen intravascular atrayendo líquido del espacio intersticial, diluyendo la masa eritrocitaria restante.

Evaluación de la Gravedad y Manejo Inicial

La gravedad de una hemorragia digestiva no se mide por el hematocrito, sino por el **compromiso hemodinámico**.

Orden de Compromiso Hemodinámico

Ante una pérdida de volumen, el organismo responde en un orden predecible: 1. **Taquicardia:** Es el signo más precoz. 2.

Ortostatismo: Caída de la presión arterial o aumento de la frecuencia cardíaca al ponerse de pie. 3. **Hipotensión arterial:** Indica una pérdida de volumen crítica (Shock hipovolémico).

Manejo General (ABC)

El tratamiento inicial es idéntico para HDA y HDB, centrándose en la estabilización: **Vía Venosa:** Instalación de dos vías venosas periféricas gruesas y cortas. **Cristaloides:** Reposición de volumen con **Suero Fisiológico** o Ringer Lactato. **Transfusión de Glóbulos Rojos:** No es el manejo inicial. Se reserva para pacientes con anemia persistente tras la reanimación o en casos de sangrado activo masivo con inestabilidad que no responde a cristaloides. **Estudio Endoscópico:** Una vez estabilizado el paciente, se procede a la endoscopia o colonoscopia para diagnóstico y terapia.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca espere el resultado del hematocrito para iniciar la reanimación con fluidos. La clínica de shock (taquicardia/hipotensión) manda en la conducta inicial.

Hemorragia Digestiva Alta (HDA)

Principales Causas y Clínicas Específicas

- Válices Esofágicas:**
 - Contexto:** Pacientes con **Daño Hepático Crónico (DHC)** o cirrosis.
 - Clínica:** Suele ser una hemorragia masiva y catastrófica con hematemesis profusa.
 - Laboratorio:** Buscar estigmas de falla hepática, como caída de la protrombinemia o alargamiento del tiempo de protrombina (TP).
 - Manejo Específico:** Además del suero y la endoscopia, se debe administrar **Terlipresina** endovenosa (o somatostatina/octreotide). Se requiere profilaxis para **Peritonitis Bacteriana Espontánea** con antibióticos y **Vitamina B1 (Tiamina)** para prevenir la **Encefalopatía de Wernicke** en pacientes alcohólicos.
2. **Úlcera Gastroduodenal:** **Contexto:** Antecedente de síndrome ulceroso (dolor epigástrico urente que empeora en ayunas). **Clínica:** Se manifiesta frecuentemente como melena. **Manejo Específico:** Administrar **Omeprazol** (u otros IBP) endovenoso en dosis altas.
3. **Síndrome de Mallory-Weiss:** **Fisiopatología:** Desgarro de la mucosa en la unión gastroesofágica debido a esfuerzos violentos. **Clínica:** Típica historia de **vómitos alimentarios repetidos seguidos de hematemesis**. **Pronóstico:** Generalmente es autolimitado y de buen pronóstico. Si el paciente está estable, se puede observar sin necesidad imperativa de intervención agresiva.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla del 10%: Un 10% de las hemorragias que parecen bajas (hematoquecia) tienen en realidad un origen alto (HDA masiva con tránsito rápido). Siempre considere realizar una EDA si la colonoscopia no encuentra la causa en un sangrado masivo.

Hemorragia Digestiva Baja (HDB)

Causas Frecuentes

Enfermedad Diverticular: Es la causa más común de HDB masiva. El sangrado ocurre porque el divertículo se hernia justo por donde las arterias penetran la capa muscular, dejando el vaso expuesto. No debe confundirse con la **Diverticulitis**, que es un proceso inflamatorio/infeccioso. **Angiodisplasias:** Malformaciones vasculares, comunes en adultos mayores. **Cáncer de Colon:** Suele dar sangrado crónico u oculto, pero puede presentarse como HDB aguda. **Divertículo de Meckel:** Causa importante a considerar en la población pediátrica.

Algoritmo de Manejo según Gravedad

- #### 1. HDB No Masiva (Paciente Estable)
- Estabilización inicial y régimen cero.
- Preparación de colon:** Se administran soluciones laxantes para limpiar el colon de deposiciones.
- Colonoscopia diferida:** Se realiza idealmente 24 horas después, con el colon limpio para visualizar correctamente la lesión.
- Si la colonoscopia no localiza el origen, el siguiente paso es un **TAC con enteroclisia** para buscar lesiones en el intestino delgado.
- #### 2. HDB Masiva (Inestabilidad Hemodinámica)
- Cuando el sangrado es tan profuso que no permite preparación de colon:

- **Colonoscopia Urgente:** Se intenta identificar el sitio, aunque la visualización suele ser mala por la sangre y las deposiciones.
- **EDA de Urgencia:** Si la colonoscopia no localiza el sangrado, se debe descartar una HDA masiva (la "regla del 10%").
- **Angiografía Mesentérica:** Si no se localiza por endoscopia, la angiografía es útil porque puede ser **terapéutica** (embolización del vaso sangrante). Requiere un débito de sangrado activo (>0.5 ml/min).
- **Cintigrafía con Glóbulos Rojos Marcados:** Útil para localizar sangrados intermitentes o de menor débito.
- **Cirugía (Hemicolecotomía Derecha):** Si todos los métodos fallan y el paciente sigue inestable. Se prefiere la colectomía derecha porque la mayoría de las HDB masivas que no se encuentran inicialmente se localizan en el colon derecho.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, si preguntan por el manejo de una HDB masiva que no se localiza en la colonoscopia, el siguiente paso lógico es la **Endoscopia Digestiva Alta (EDA)** para descartar un origen alto.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 55 años con hematemesis masiva, hipotenso, con antecedente de cirrosis hepática. La protrombinemia está en 40%. ¿Cuál es el fármaco específico que debe agregarse al manejo inicial?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Hemorragias Digestivas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- HDA: melena/hematemesis; HDB: hematoquecia/rectorragia; separadas por el ángulo de Treitz
- Gravedad determinada por hemodinamia (taquicardia→ortostatismo→hipotensión), NO por hematocrito
- Manejo inicial: suero fisiológico IV + endoscopia/colonoscopia; transfusión solo si anemia persistente posterior
- Várices esofágicas: masiva, daño hepático crónico, agregar terlipresina IV
- Úlcera gastroduodenal: melena, síndrome ulceroso previo, agregar omeprazol IV
- Mallory-Weiss: vómitos alimentarios→hematemesis, buen pronóstico, autolimitado
- HDB masiva: escala de estudio = colonoscopia→endoscopia alta→angiografía→cirugía (hemicolecotomía derecha)
- Enfermedad diverticular: causa más grave de HDB; divertículo de Meckel en niños

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HEMORRAGIAS DIGESTIVAS)**PREGUNTA 1**

Paciente de 55 años con hematemesis masiva, hipotenso, con antecedente de cirrosis hepática. La protrombinemia está en 40%. ¿Cuál es el fármaco específico que debe agregarse al manejo inicial?

- ☐ A) Omeprazol endovenoso
- ☐ B) Terlipresina endovenosa
- ☐ C) Transfusión de glóbulos rojos
- ☐ D) Ranitidina endovenosa
- ☐ E) Ácido tranexámico

PREGUNTA 2

¿Cuál de los siguientes parámetros determina la gravedad de una hemorragia digestiva alta al momento de la presentación?

- ☐ A) Hematocrito
- ☐ B) Hemoglobina
- ☐ C) Frecuencia cardíaca y presión arterial
- ☐ D) Volumen de la hematemesis
- ☐ E) Recuento de plaquetas

PREGUNTA 3

Paciente con hemorragia digestiva baja masiva. Se realiza colonoscopia urgente sin localizar el sitio de sangrado. ¿Cuál es el siguiente paso?

- ☐ A) Repetir colonoscopia con mejor preparación
- ☐ B) Endoscopia digestiva alta
- ☐ C) TAC de abdomen
- ☐ D) Cirugía inmediata
- ☐ E) Cintigrafía con glóbulos rojos marcados

RESUMEN: HEMORRAGIAS DIGESTIVAS

Clase sobre hemorragia digestiva alta (HDA) y baja (HDB). La HDA (sobre el ángulo de Treitz) se presenta con melena o hematemesis; la HDB (bajo el ángulo de Treitz) con hematoquecia o rectorragia. Ambas se clasifican en masiva o no masiva según compromiso hemodinámico. El manejo inicial es igual: suero fisiológico IV + endoscopia/colonoscopia. La gravedad la determina la hemodinamia (taquicardia, ortostatismo, hipotensión), NO el hematocrito. Las causas principales de HDA son várices esofágicas (masiva, terlipresina), úlcera gastroduodenal (melena, omeprazol IV) y Mallory-Weiss (vómitos seguidos de hematemesis, buen pronóstico). En HDB, las causas principales son enfermedad diverticular (la más grave), angiodisplasias y cáncer de colon. Si no es masiva: colonoscopia en 24h con preparación. Si masiva: colonoscopia urgente, luego endoscopia alta, angiografía mesentérica y cirugía (hemicolectomía derecha).